LESIONES BENIGNAS DE LA MAMA

DR. PABLO DURAN

ENFERMEDADES CONGÉNITAS Y GINECOMASTIA

- Congénitas: politelia (pezón supernumerario) y mama supernumeraria, generalmente sin tratamiento salvo por estética.
- Ginecomastia: crecimiento del tejido glandular mamario en hombres; frecuente en la pubertad (70% de los niños) y por exceso de estrógeno.
- Otras causas: hipertiroidismo, cirrosis hepática, falla testicular, síndrome de Klinefelter, tumores productores de hCG, tumores testiculares y medicamentos.

QUISTES, ABSCESOS Y TUMORES BENIGNOS

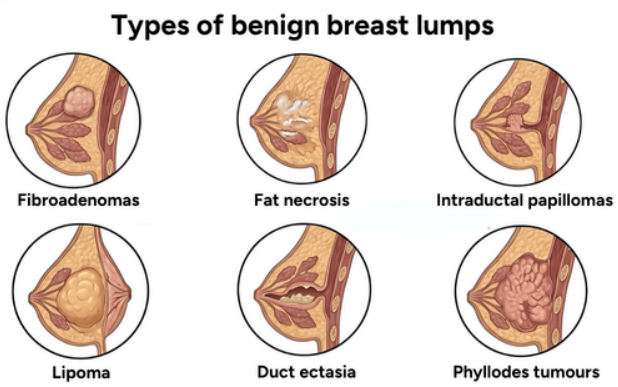
- Quistes mamarios: diagnóstico por ultrasonido; se puede aspirar con aguja si son sintomáticos.
- Absceso mamario: se distingue si ocurre en lactancia o no; puede formar una fístula si no se trata a tiempo.
- Fibroadenoma: tumor benigno sólido más frecuente; se puede resecar si crece o preocupa a la paciente.
- Tumor Phylloides: puede requerir mastectomía simple según el tamaño y las características.

TUMORES RAROS DE LA MAMA

- Lipoma: tumor benigno de tejido graso, blando y móvil; no requiere tratamiento salvo si crece o duele.
- Hamartoma: lesión bien delimitada con tejido glandular, fibroso y graso ("seno dentro de un seno" en la imagen).
- Necrosis grasa: tras trauma o cirugía previa; puede simular un cáncer en la imagen, por eso a veces requiere biopsia.

SECRECIÓN POR EL PEZÓN

- Factores de alto riesgo: edad >60 años, secreción sanguinolenta o verde/transparente, de un solo ducto, o con anormalidad al examen.
- Bajo riesgo: bilateral, edad <40 años, secreción serosa, prolactina alta, sin anormalidades al examen.
- Papiloma intraductal: causa frecuente de secreción; se diagnostica con ductograma o ultrasonido.



DOLOR MAMARIO (MASTODINIA)

- Solo 2-7% de las pacientes con dolor mamario tienen cáncer; evaluar si es cíclico o constante, uni o bilateral, y si hay una masa asociada.
- Causa más frecuente: osteocondritis (síndrome de Tietze); unilateral en 95% de los casos.
- Tratamiento: naproxeno 550mg al día por 15 días, cambiar de sostén, evitar ejercicios tipo push-ups.
- Eczema del pezón: tratar con betametasona 0.1% y acetato de aluminio por 2 semanas; descartar enfermedad de Paget si no mejora.

GALACTORREA

- Secreción láctea no asociada a embarazo o lactancia; causas: hiperprolactinemia, hipotiroidismo, medicamentos (antipsicóticos, antihipertensivos).
- Evaluación: niveles de prolactina y TSH; imagen de la hipófisis si la prolactina está muy elevada.